

# PFCMVP 파트 1 — 단백질·지방·탄수화물 (번역)

출처: AFMCP Chap4 PFCMVP Part1 Transcript

---

## 단백질 (Protein)

완전단백질: 필수아미노산 9가지 모두 포함 — 동물성(육류·생선·달걀·유제품), 대두, 퀴노아

불완전단백질: 필수아미노산 일부 부족 — 대부분의 식물성 단백질; 상호 보완 섭취 필요

소화율: 동물성 단백질 >95%, 식물성 85–90%; 소화 기능 저하 시 흡수율 추가 감소

권장 섭취량: 일반 성인 0.8g/kg, 근감소증·수술·고령자 1.2–2.0g/kg

단백질 부족 징후: 근육량 감소, 모발·손발톱 약화, 상처 치유 지연, 면역력 저하

단백질 과잉: 신장 기능 저하 환자에서 주의; 인산·황 대사산물 증가

## 지방 (Fats & Oils)

포화지방산(SFA): 상온에서 고체, 동물성·코코넛오일; 과다 섭취 시 LDL ↑, 염증 ↑

단일불포화지방산(MUFA): 올리브오일·아보카도·견과류; 심혈관 보호 효과

다가불포화지방산(PUFA): 오메가-3·오메가-6; 체내 합성 불가 → 반드시 식이로 섭취

오메가-3 (EPA·DHA): 항염, 심혈관 보호, 뇌 기능; 등푸른 생선·아마씨·호두

오메가-6 (리놀레산): 염증 촉진 경향; 현대 식이에서 오메가-3 대비 과다 (이상 비율 4:1, 현실 15–20:1)

트랜스지방: 부분경화유에서 생성; 심혈관 위험 최고 수준 — 완전 회피 권고

지방 부족 징후: 건조 피부·모발, 지용성 비타민(A·D·E·K) 흡수 불량, 호르몬 불균형

## 탄수화물 (Carbohydrates)

단순당: 빠른 혈당 상승, 인슐린 급증; 가공식품·음료·정제 곡물에 다량 포함

복합당: 서서히 분해되어 혈당 안정; 통곡물·채소·콩류

혈당지수(GI): 식품이 혈당을 올리는 속도 (포도당=100 기준); GI 55 이하 = 저혈당지수

혈당부하(GL):  $GI \times \text{탄수화물 함량} / 100$ ; 실제 혈당에 미치는 영향 더 정확히 반영

식이섬유: 수용성(콜레스테롤·혈당 조절), 불용성(장 운동 촉진); 목표 25–35g/일

저항성 전분: 소화되지 않고 장내 미생물 먹이로 작용 — 식힌 밥·감자·바나나(덜 익은 것)

탄수화물 과다 징후: 고TG, 저HDL, 복부 비만, 인슐린 저항성